

Infectii micotice cutaneo- mucoase

Infectii micotice **superficiale** - specii keratinofile, pluricelulare, multiplicare sexuata (ciuperci filamentoase)

- Epidermophyton
- Tricophyton
- Microsporum

Specii partial keratinofile,
unicelulare, multiplicare prin diviziune:

- Candida

Examene de laborator pentru fungi patogeni

- Exam micologic direct
avec KOH 20%
(filamente miceliene)
- Cultura –mediu
Sabouraud sau
Nicholson

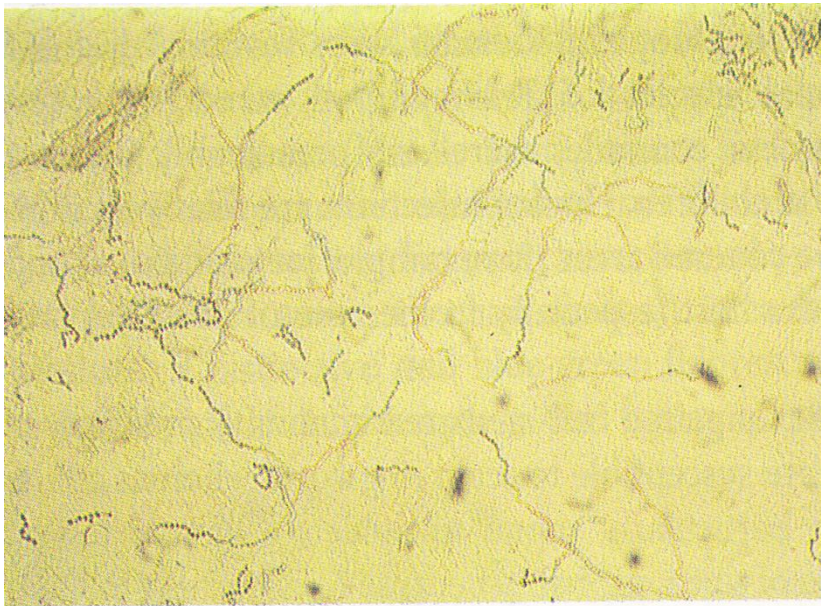


Fig. 13.26 *Trichophyton rubrum*. The underside of the plate is a red colour, hence the adjective rubrum. It is the most common cause of dermatophyte infections in the UK. By courtesy of Dr Y.M. Clayton, Institute of Dermatology.



Fig. 13.27 *Trichophyton mentagrophytes*. A white granular colony is characteristic. By courtesy of Dr Y.M. Clayton, Institute of Dermatology.

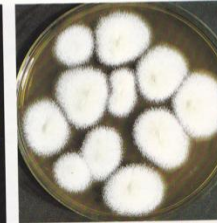


Fig. 13.28 *Trichophyton mentagrophytes* var. *interdigitale*. The colonies are creamy and powdery. By courtesy of Dr Y.M. Clayton, Institute of Dermatology.

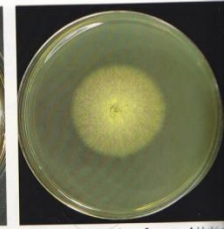


Fig. 13.29 *Epidermophyton floccosum*. A khaki or olive-green powdery colony forms on culture. By courtesy of Dr Y.M. Clayton, Institute of Dermatology.

Forme clinice de infectii fungice produse de ciuperci filamentoase

Tinea sau epidermofitie

Localizare:

- tinea pedis
- tinea inguinalis
- tinea manum
- tinea corporis
- tinea faciei
- Tinea capitis
- onicomicoze

tinea pedis

- Spatii interdigitale IV si III
- Eritem discret si descuamare
- Depozit alb fetid
- Fisuri interdigitale (poarta de intrare erizipel!!!)
- Prurit, arsura inconstant



tinea pedis



- Afectarea întregii plante si a marginilor laterale (**in mocasin**)

tinea inguinalis = tinea cruris



- Unilateral/bilateral in zona inghinala
- Placard eritemato-scuamos
- Contur arcuat, circinat, extindere centrifugă
- Margine eritematoasa activă cu descuamare furfuracee,
- Centrul leziunii aparent cu aspect normal
- Prurit sau arsura

tinea inguinalis= tinea cruris

- Fara tratament corect persista indefinit, se extinde progresiv
- Tratamentul eronat cu dermocorticoizi produce ameliorari temporare, urmate de recidiva mai extinsa si leziuni micronodulare relativ rezistente la terapia antimicotica



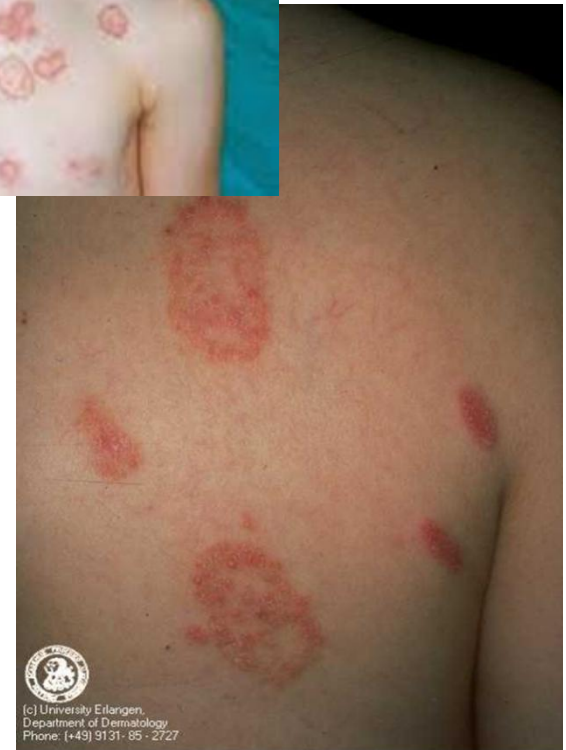
tinea manum

- Unilaterală (mâna dominantă) o mână două picioare
- Eritem și descuamare furfuracee discretă
- Vezicule și descuamare anulară
- Ex. micologic –dg. dif cu eczema dishidrotică



tinea corporis

- Leziuni anulare, pruriginoase
- mai multe inele concentrice cu eritem si scuame
- Multiple
- Trunchi si membre
- copii/adulti +animale cu blana infectate



tinea corporis



tinea faciei

- Placard eritematos difuz
- Vezicule, cruste, scuame
- Dg dificil-ex. micologic



diagnostic diferencial tinea

- Eczeme (de contact, atopica, dishidrotica)
- Psoriazis palmoplantar
- Alte tipuri de intertrigo

tratamentul în tinea pedis, manum, corporis, faciei

Local:

- **Antimicotice topice** (creme, geluri): clotrimazol, miconazol, bifonazol, fenticonazol, terbinafină et ciclopiroxolamine 4-6 săptămâni
- Dezinfectia obiectelor personale
- În cazuri extinse, severe, non-responsive la tratamentul local: tratament oral cu terbinafină sau fluconazol sau itraconazol pentru 4-6 săptămâni

Tinea capitis (pilomicoze/tricofitii)

Scalp (si barba)

- Tricofitie non-inflamatorie
- Tricofitie inflamatorie

Tricofitii non-inflamatorii

- **Microsporia**
- **Tricofitia uscata a scalpului**
- Specii antropofile cu tropism pentru keratina pilara imatura de la nivelul scalpului
- Intens contagioase, colectivitati de copii
- Infectia fungica afecteaza tija dupa emergenta din orificiul pilar, ruptura ei la suprafata pielii
- Se vindeca spontan la pubertate

Tricofitia uscată

- Multiple placi alopecice
- Firul de par rupt la nivele diferite, scuame aderente, descuamare furfuracee
- examen cu lampa Wood - negativ



Tricofitia inflamatorie

- Specii zoofile (animale cu blana)
- reactie inflamatorie intensa
- Scalp copii: **Kerion Celsi**
- Barba sau mustață după pubertate **sicosis tricofitic**



Kerion Celsi/sicosis trichofitic

- Pseudo-tumora inflamatorie (cm)
- Eritem, tumefiere, durere
- Cruste purulente care aglutineaza firele de par rupte, epilate
- La presiunea leziunii apar picaturi de puroi prin orificiile foliculare
- Stare generala alterata
- Adenopatie reactiva locala



Kerion Celsi/sicozis tricofitic

- se complica cu suprainfectie stafilococica
- Ex. micologic (fir de par) si ex. bacteriologic
- Fara tratament prompt si corect se vindeca cu alopecie cicatriciala definitiva



tratamentul în tricofitii

Tratament oral:

- **antimicotice** sistemice (Terbinafina, Griseofulvina)
- 4-6 săptămâni
- Asociere inițială pentru 7-10 zile atb antistafilococice (Kerion Celsi/sicozis tricofitic)

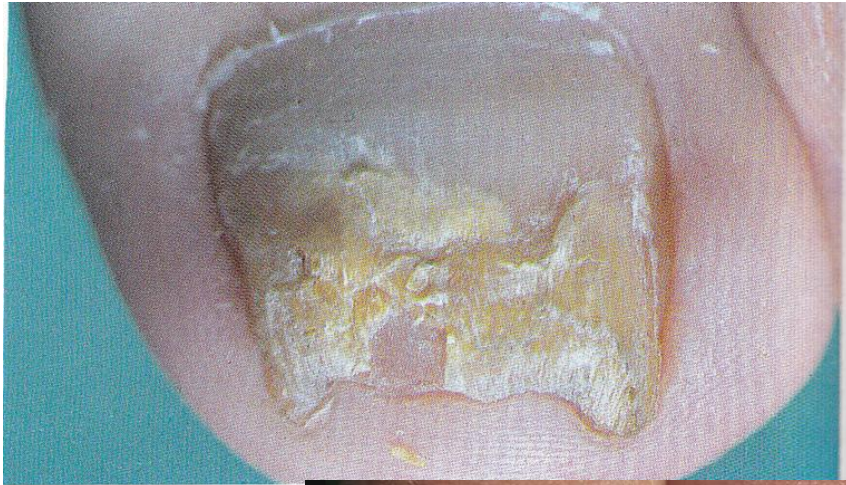
Tratament local:

- soluții antiseptice
- Manopere locale: epilarea mecanică a firelor de păr
- Antimicotice topice

Onicomicoze

- Afectare directa sau co-afectare (tinea pedis/manum) a aparatului unghial
- Frecvent: police si haluce
- Cazuri severe, neglijate: toate cele 20 unghii
- Lama unghiala **ingrosata** (hiperkeratoza subunghiala), culoare modificata
- Marginea libera neregulata,
- Santuri transversale si longitudinale
- Lama unghiala ingrosata devine friabila (distrofie totala)
- dezlipita de patul unghial (onicoliza)
- capata aspect de gheara (onicogrifoza)

onicomicoza



Tratamentul în onicomicoză

- Tratament oral: antimicotice sistemice (fluconazol, itraconazol, terbinafina) 3-6 luni
- Tratament local: în cazul leziunilor distale, fără afectarea matricei unghiale (lacuri de unghii antimicotice)

Candidoze cutaneo-mucoase

Candida albicans:

- ciuperca saprofita (tub digestiv, vagin, 30% cavitate orala)
- Conditionat patogena → factori favorizanti:
 - Tratament prelungit cu atb oral, corticosteriozi
 - Citostatice
 - Anticonceptionale orale
 - Diabetul zaharat
 - Sarcina
- Afecteaza mucoasele si pliurile
- Reinfectia de la partenerul sau partenerului netratat
- Reinfectia din tubul digestiv propriu

Stomatita candidozică acută

- Debut cu senzație de arsură și uscăciune bucală
- Eritem intens al mucoasei (aspect lăcuit)
- Depozit albicios, detasabil, cremos
- Eroziuni dureroase
- Imunodepresie!!!
- Tratament oral: Fluconazol 50 mg/zi 7 zile



Cheilita candidozică acută

Aspect nespecific:

- Eritem al buzelor
- Descuamare furfuracee
- Fisuri dureroase
mediolabiale

Necesita ex. micologic
(cultura Candida)

Tratament local:
antimicotice topice



Angulus candidozic (perléche-ul candidozic)

- Fisuri dureroase si eritem comisuri bucale
- Depozit albicios, detasabil
- Uni/**bilateral**
- Imunodepresie!!!



Intertrigo-ul candidozic al adultului

- Sub-mamar, inghinal, interfesier, axilar
 - placard eritematos, fisuri, pustule în periferie
- Tratament local si oral



Paronichia candidozică

- **Acută:** tumefactia si eritemul repliului unghial, durere locala, secretie purulenta la presiune, unul /mai multe degete afectate
- **Cronică:** eritemul si tumefactia dureroase se reactiveaza pe fondul unei tumefactii discrete cu descuamare, disparitia cuticulei, modificarea aspectului lamei unghiale (onicodistrofie secundara), onicomicoza
 - Femei, activitati menajere, manicura
 - Dg. Dif. cu paronichia bacteriana (se pot asocia)

